

基于机器学习与关联网络的古代玻璃成分分析

摘要

NIPT（无创产前检测）是保障胎儿健康的重要技术，其准确性与实施时点紧密相关。当前对所有孕妇采用统一的检测时点方案忽略了个体差异，可能导致检测失败或延误诊治，增加潜在风险。为不同特征的孕妇群体制定个性化的检测时点策略，并为女胎建立有效的异常判定方法，是提升该技术临床应用价值的核心议题。本文基于孕妇的临床与基因测序数据，建立了一系列数学模型，以解决上述问题。

针对问题一，为分析胎儿 Y 染色体浓度与母体指标的关系，本文在数据清洗后，比较了四种回归模型。最终选定非线性混合效应模型，该模型能同时反映群体趋势与个体差异。模型结果显示，Y 染色体浓度随孕周呈现显著的 S 型变化，而孕妇 BMI 的影响边缘显著。模型的条件决定系数为 0.92，其中固定效应解释了 41.97% 的变异，而个体随机效应解释了 49.61% 的变异，表明个体差异是浓度变化的主导因素。

针对问题二，为给不同 BMI 的男胎孕妇确定风险最小化的检测时点，本文构建了一个双层优化决策模型。该模型首先通过 K 均值聚类对孕妇进行分组，然后基于一个由延迟风险与机会成本构成的量化风险函数，采用网格搜索求解各组的最优时点。求解结果表明，将孕妇划分为七个组别时，全体孕妇的加权平均总风险最低，为 4.07。各组的最佳检测时点与 BMI 呈正相关趋势，时间范围从 10.00 周至 22.43 周。

针对问题三，为在多因素与达标比例约束下优化检测时点，本文建立了一个包含身高、体重、年龄等多变量的非线性混合效应预测模型。通过 K 均值聚类将孕妇分为四个群组，并在满足特定 Y 染色体浓度达标比例的约束下，以最小化总期望风险为目标进行时点优化。蒙特卡洛模拟结果显示，模型推荐的最优时点均值在不同检测误差水平下保持稳定，验证了决策方案的稳健性。

针对问题四，为建立女胎染色体异常的判定方法，本文将该问题构建为一个二元分类任务。在采用合成少数类过采样技术处理数据不平衡问题后，训练并比较了逻辑回归、决策树与 XGBoost 三种模型。最终选择综合性能最优的逻辑回归模型，其在测试集上的异常类 F1 分数为 0.44，AUC 值为 0.80。通过 SHAP 方法对模型进行解释，验证了其判定逻辑与临床知识的一致性。

综上所述，本文系统地研究了 NIPT 检测中的时点选择与异常判定问题。研究工作不仅量化了孕妇个体差异对 Y 染色体浓度的影响，还为不同特征的孕妇群体提供了风险最小化的动态检测时点建议。此外，建立的女胎异常判定模型为临床诊断提供了数据支持。这些模型与结论共同构成了一套个性化的 NIPT 决策支持方案，有助于提升检测的成功率与准确性，降低孕妇的潜在风险，具有实际的临床应用价值。

关键字：卡方检验 地球化学 质量平衡分析理论 SHAP 值 支持向量机 中心化对数比 图套索算法 鲁汶算法

一、问题背景

NIPT（无创产前检测）是一种现代产前筛查技术，它通过分析孕妇外周血中来自胎儿的游离 DNA 片段，评估胎儿患有染色体非整倍体疾病的风险^[1]。临床上重点关注三类由染色体数目异常引起的病症，分别为唐氏综合征、爱德华氏综合征与帕陶氏综合征，它们分别对应胎儿 21 号、18 号与 13 号染色体的异常^[2]。该检测的有效性依赖于胎儿性染色体浓度：男胎 Y 染色体浓度需达 4%^[3]，女胎 X 染色体浓度则需无异常。

检测时点的选择是影响检测有效性的一个重要变量。若检测时间过早，胎儿游离 DNA 浓度可能不足，这将导致检测结果无法保证准确性。反之，若检测时间过晚，则可能会延误后续的临床决策。根据临床经验，孕 12 周以内发现异常属于低风险，孕 13 至 27 周发现属于高风险^[4]，而孕 28 周以后发现则为极高风险。

临床实践常依据身体质量指数 BMI 对孕妇分组并推荐统一检测时点，但该方法因忽略年龄、孕情等个体差异，并非最优。因此，需建立数学模型对孕妇进行合理划分，确定各群体的最佳检测时点，以平衡检测可靠性并降低延迟发现的风险。

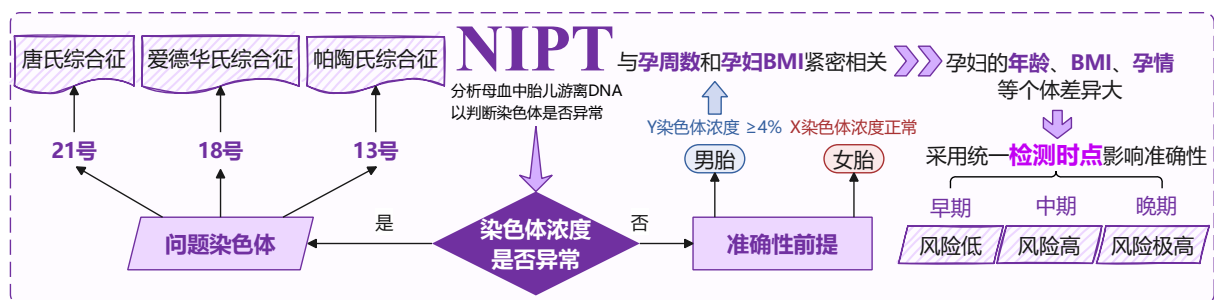


图 1 问题背景示意图

二、问题重述

问题一：分析胎儿染色体浓度与孕妇孕周数和身体质量指数等指标的相互关系，并建立相应的关系模型。

问题二：针对男胎孕妇，依据其身体质量指数进行分组，确定各组的最佳无创产前检测时点以使潜在风险最小，并分析检测误差造成的影响。

问题三：考虑身高，体重，年龄等多重因素与检测误差，根据男胎孕妇的身体质量指数进行分组，并给出每组的最佳无创产前检测时点，以最小化孕妇潜在风险并顾及 Y 染色体浓度达标比例。

问题四：建立女胎染色体异常的判定方法，运用 Z 值，GC 含量，读段数及身体质量指数等多种因素，以识别 21 号，18 号和 13 号染色体的非整倍体异常。

三、问题分析

针对问题一，任务是建立 Y 染色体浓度与孕妇孕周及 BMI 等指标的关系模型。考虑到数据中可能存在的非线性趋势与个体差异，本文将构建非线性混合效应模型。该模型能分离并量化群体共性趋势与个体特异性影响，通过模型择优与显著性检验，最终确定各因素的量化关系。

针对问题二，需要依据孕妇 BMI 分组并确定各组的最佳 NIPT 时点，以最小化总体风险。该决策需要在规避检测失败风险与延迟检测风险间进行权衡。本文将此问题构建为优化模型，通过定义包含这两部分风险的总风险函数，对不同 BMI 分组求解使该函数最小的最佳检测时点。

针对问题三，任务是在问题二的基础上，综合身高、体重、年龄等多维因素，并满足 Y 染色体浓度达标比例的约束，进行 NIPT 时点优化。本文将建立一个多因素预测模型，并在此基础上构建带约束的优化问题，其目标是在确保各分组检测达标率满足要求的前提下，求解能使整体风险达到最小化的最优检测时点，并分析检测误差对结果稳定性的影响。

针对问题四，核心是为女胎建立染色体异常的判定方法。此问题可被视为一个二元分类任务。本文将利用 Z 值、GC 含量、读段数等生物信息学指标作为特征，训练机器学习分类器。考虑到异常样本稀少，将对数据不平衡问题进行处理，并通过性能评估选出最优模型，用于女胎异常的判定。

全文框架如图 2 所示：

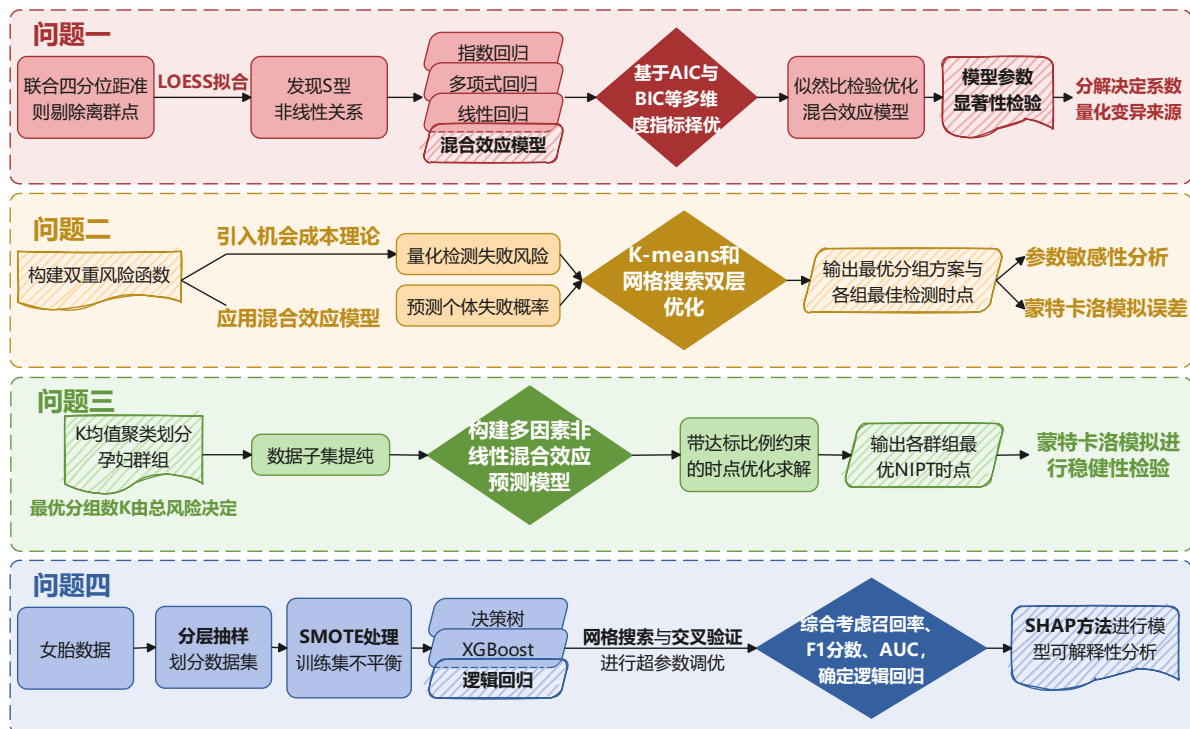


图 2 全文框架示意图

四、模型假设

为保证后续模型构建的合理性与结果的有效性，本文提出以下基本假设：

1. 提供的 NIPT 检测数据是目标地区孕妇群体的无偏代表性样本。
2. 数据预处理中采用的离群点剔除准则能有效移除异常数据且不引入系统偏差。
3. 男胎 Y 染色体浓度达到或超过 4% 是判断 NIPT 结果准确的有效临床标准。
4. 胎儿异常的健康风险随孕周增长，其增长模式可通过分段函数进行近似描述。
5. 一次 NIPT 检测失败后，下一次检测将在一个固定的时间间隔后进行。
6. 不同孕妇间 Y 染色体浓度的差异服从正态分布。
7. 附件中提供的女胎染色体非整倍体检测结果是准确的，可作为分类模型训练的真实标签。

五、符号说明

本文后续章节中所使用的主要数学符号及其说明如表 1 所示。

表 1 符号说明表

符号	说明
Y_{ij}	第 i 位孕妇在第 j 次检测时的 Y 染色体浓度
GW_{ij}	第 i 位孕妇在第 j 次检测时的孕周
BMI_{ij}	第 i 位孕妇在第 j 次检测时的身体质量指数
β	模型中的固定效应系数数量
u	模型中的随机效应项
e_{ij}	模型的随机误差项
LL	对数似然值
k	模型中的参数数量
n	样本总量
AIC	赤池信息准则
BIC	贝叶斯信息准则
$RMSE$	均方根误差
$R^2_{marginal}$	边际决定系数，由固定效应解释的方差比例
$R^2_{conditional}$	条件决定系数，由固定和随机效应共同解释的方差比例
$R_{late}(t_i)$	在检测时点 t_i 的累积健康风险
$R_{fail}(t_i)$	在检测时点 t_i 的检测失败机会成本风险
Δt	两次检测之间的固定时间间隔

六、模型准备

为了后续模型的建立与求解，本文进行如下模型准备，即数据清洗、特征工程等。具体机制如图 3 所示。

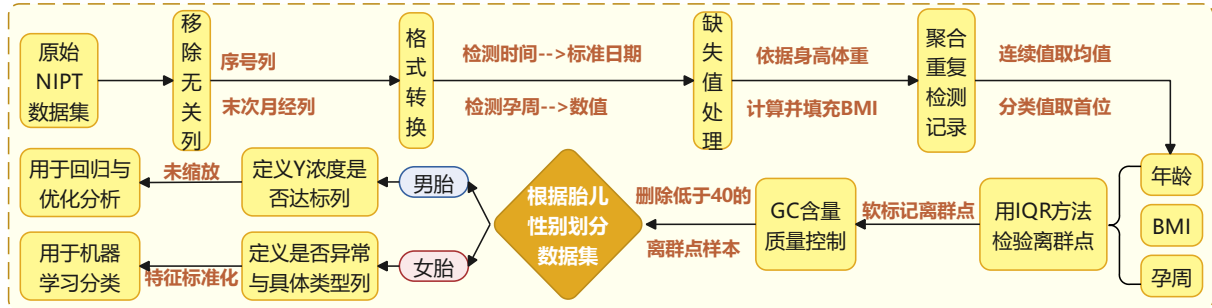


图 3 模型准备机制

6.1 数据清洗

6.1.1 缺失值处理与数据整合

为简化数据集，我们移除了与建模任务无直接关联的序号列。随后，我们对数据集中各变量进行缺失值统计，发现末次月经时间列存在部分数据缺失。末次月经时间的主要功能为推算孕周，而数据集中已包含更为直接的检测孕周列，故将其移除。

为使原始特征能够用于定量分析，我们需要将其转化为标准的数值格式。对于纯数字格式的检测时间列，我们将其转换为标准的日期时间格式；对于文本格式的检测孕周列，我们转换为可计算的浮点数值，例如十二周加三天转化为 12.43 周。对于孕妇 BMI 指标列中的缺失值，我们利用同一条记录的身高与体重数据，依据身体质量指数的官方计算公式进行填充，该公式如下所示

$$BMI = \frac{Weight(kg)}{Height(m)^2} \quad (1)$$

与使用均值或中位数等统计量填充相比，利用已有数据进行计算能保持数据的真实性。

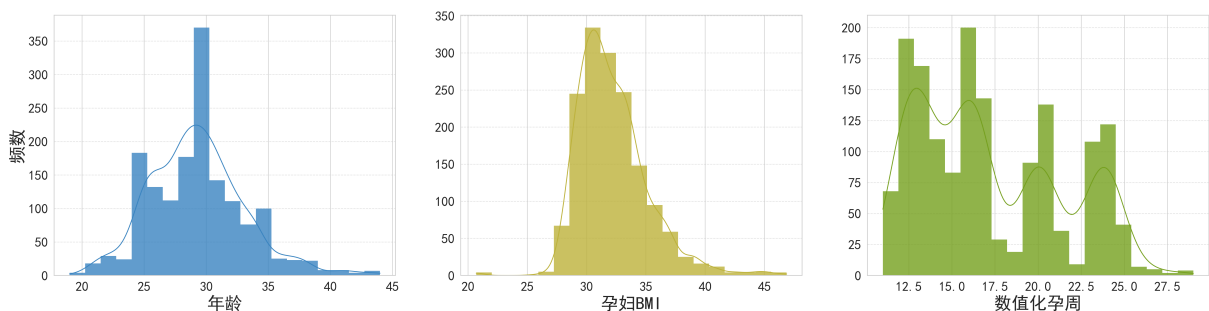


图 4 核心特征分布

完成基础清洗与计算后，数据集内核心特征的整体分布如图 4所示。该图展示了孕妇年龄，孕妇 BMI 与检测孕周三个变量的分布状况。从图中可以看出样本的年龄主要集中在 25 至 35 岁之间，孕妇 BMI 分布的峰值位于 30 附近。检测孕周则在 12 至 25 周之间呈现多个峰值，表明了检测时间点的集中性。

根据题目说明，原始数据中存在一次采血多次检测的情况，这种情况造成了数据冗余。为消除此冗余并为每个样本建立唯一的检测记录，本文以孕妇代码与检测抽血次数的组合为标识，对重复的检测条目进行聚合处理。在聚合过程中，对于连续型测量指标，采用算术平均值以平滑单次测量的随机波动。对于分类性质的状态指标，则保留其初次记录的值。

该聚合过程的效果通过图 5中的前后对比得以展示。左图显示在处理前，单个孕妇对应的所有样本的所有检测记录数从 1 条至 9 条不等，其中多数孕妇具有 3 至 6 条记录。经过聚合处理后，如右图所示，每位孕妇的有效检测次数范围缩小至 1 至 5 次，其中具有 4 次有效检测的孕妇数量最多。

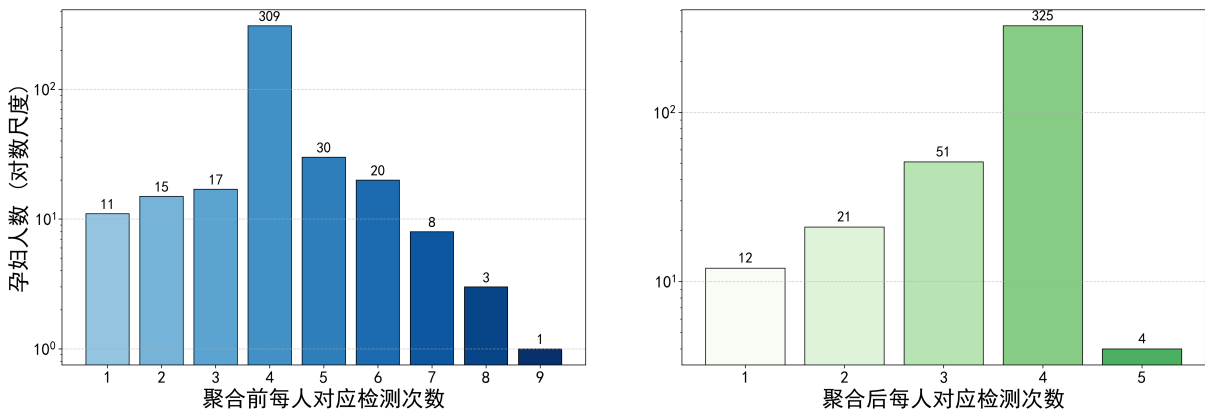


图 5 数据整合效果对比

6.1.2 异常值处理

我们首先针对年龄，孕妇 BMI 与孕周这三个核心特征执行四分位距法检验。对于识别出的离群点，本文采用软标记方法，即在数据集中新增一列用以标记样本是否为离群点，而不直接删除样本记录。离群点可能代表了真实存在的极端生理状况或数据录入错误，采用软标记策略为后续建模提供了灵活性。图 6展示了离群点分析的过程，图中每个子图的小提琴形状表示了数据的分布，红色的圆点则标记出被标准四分位距准则判定为离群点的样本。图中可见，年龄的离群点主要分布在 40 岁以上的高龄区间，孕妇 BMI 的离群点则同时出现在低于 20 的低值区域与高于 40 的高值区域，而孕周的离群点相对较少。

其次我们对 GC 含量进行质量控制。GC 含量是衡量测序质量的重要指标。处理过程结合了统计学检验与业务规则，先对 GC 含量列执行标准的 1.5 倍四分位距检验以识

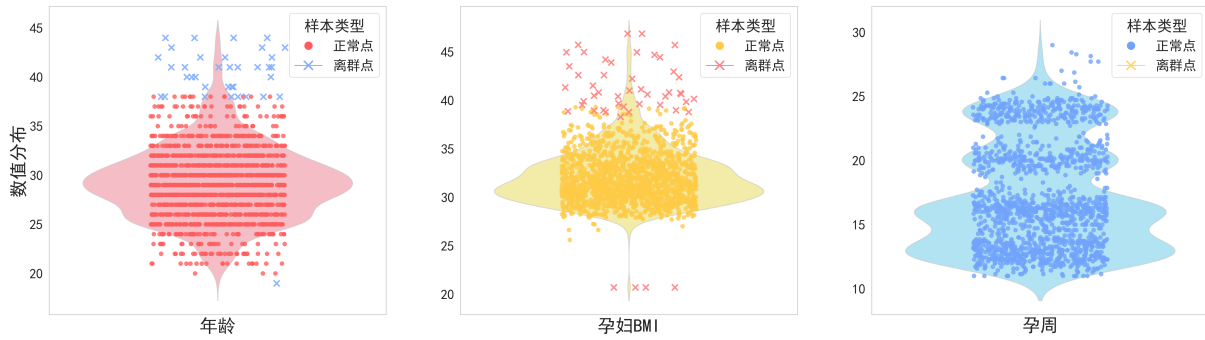


图 6 IQR 离群点分析

别出所有统计学上的离群点。然后，仅将这些离群点中数值低于 40% 的样本从数据集中直接删除。此方法能够剔除那些不仅在统计上异常，且低于业务经验常规下限的低质量测序样本。图 7 展示了处理后的数据，其中直方图展示了 GC 含量的整体分布形态近似正态分布，频数在 0.400 处达到峰值，绝大多数样本的 GC 含量分布在 0.395 至 0.405 之间，分布集中，数据质量较高。

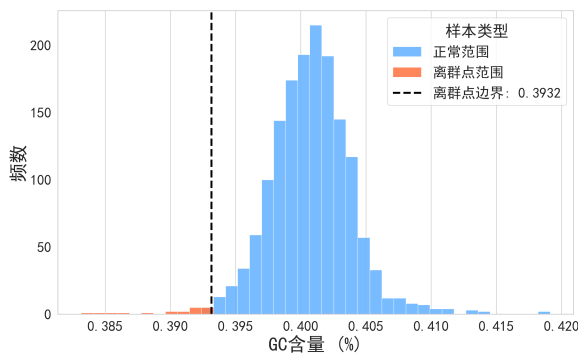


图 7 GC 含量离群点分析

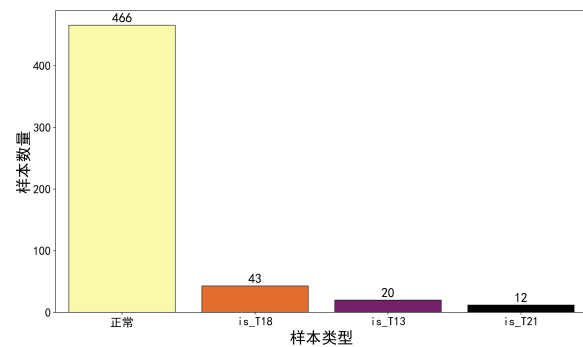


图 8 染色体异常类型分布

6.2 特征工程

为了便于后续相关数学模型的建立与求解，针对类别型变量，我们进一步进行了数据量化。

针对不同问题,我们构建了相应的目标变量。对于男胎数据,依据题目定义的 4% 阈值,我们创建了“Y 浓度是否达标”的二元分类变量。对于女胎数据,则基于染色体的非整倍体列中空白即为无异常的定义,创建了“是否异常”以及各类异常的分类目标。图 8 展示了女胎样本中正常与各类异常样本的数量分布。图中可见正常样本数量为 488 例,而 18 号, 13 号与 21 号染色体三体综合征的样本数量分别为 45 例, 22 例与 13 例。正常样本远多于异常样本,表明这是一个数据不平衡问题。

考虑到问题四需要使用机器学习分类模型,我们仅针对女胎数据的所有数值型预测

特征应用了标准化处理。标准化将所有特征转换到同一尺度，其计算方法如下

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad (2)$$

其中 x 为原始值， μ 为特征均值， σ 为特征标准差。此操作避免了模型的训练过程被原始读段数等具有极大数值范围的特征所主导，使模型能够更稳定地学习所有特征的贡献。男胎数据因主要用于回归和优化分析，保留其原始数值的物理意义更为重要，故不进行缩放。**??**展示了女胎数据中所有数值型预测变量在标准化处理前后的分布对比。每个子图呈现了同一特征在处理前后的分布形态，处理前各变量的分布中心与尺度范围各不相同，而经过标准化处理后，所有变量的分布均被调整至以 0 为中心，具有相似的尺度，这为后续机器学习模型的训练提供了同质化的输入。

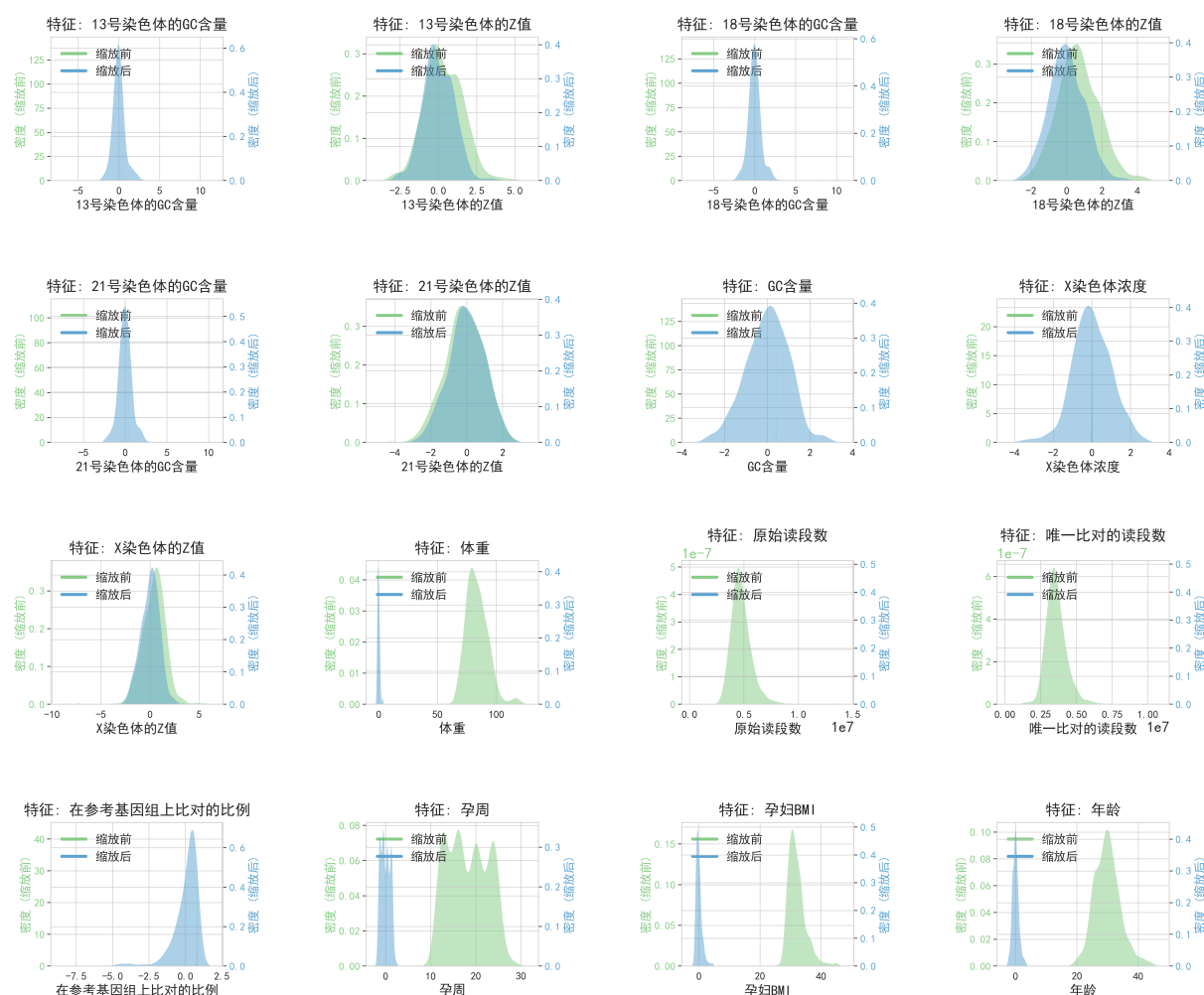


图 9 所有数值特征标准化效果对比

此外，我们还构建了部分衍生特征。我们依据题目对风险的定义，创建了与孕周对应的风险等级特征。同时，为进行时序分析，还计算了每次检测距首次检测的天数。

七、问题一：关系模型的建立与求解

为识别影响男胎 Y 染色体浓度的主要因素并量化其作用，我们先构建最终数据集，再通过探索性分析与迭代建模建立能反映数据规律的关系模型。具体流程见 图 10。

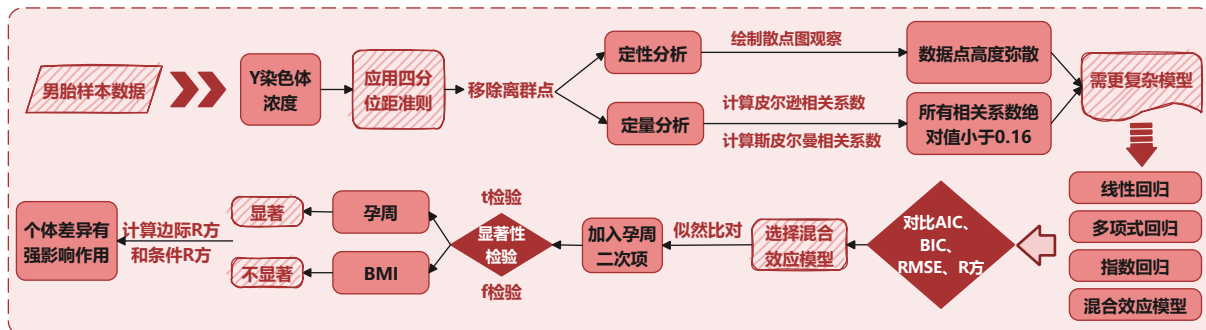


图 10 关系模型的建立与求解流程

7.1 数据准备与探索性分析

本章的分析始于经过初步处理的男胎样本数据。为保证模型的稳健性，避免极端值对模型参数估计产生不当影响，我们对 Y 染色体浓度、孕妇 BMI、年龄与孕周四个核心变量应用了四分位距准则进行离群点检测。对于孕妇 BMI、年龄与孕周，我们直接使用了之前的软标记记录。在联合筛选过程中，任何在上述四个变量中至少存在一个离群点的样本记录均被移除。经过筛选，共 54 条记录被剔除，最终形成了包含 944 条高质量观测记录的分析数据集。该数据清洗过程的效果如图 11 所示，其中的蓝色部分和橙色部分分别对应了保留样本与剔除样本，而红色虚线标示了依据四分位距准则计算得出的离群点判断上边界。处理后的数据分布更为集中，减少了极端值可能带来的干扰。

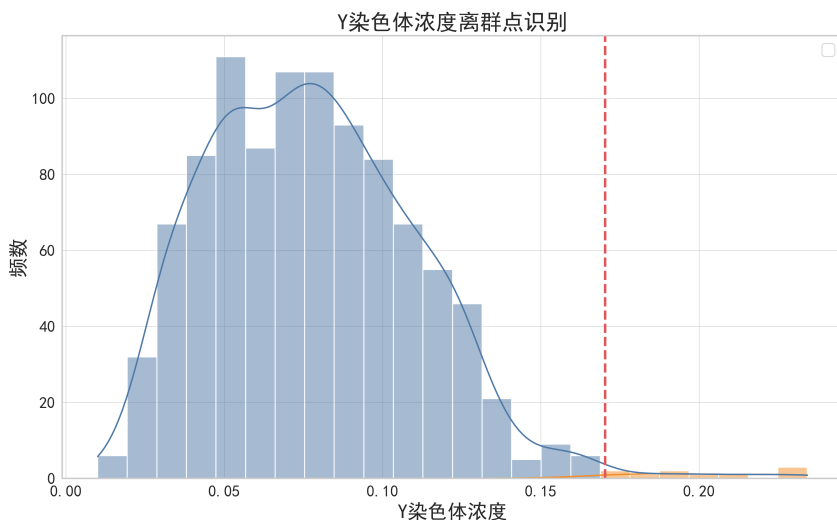


图 11 Y 染色体浓度离群点剔除过程

在构建正式模型之前，我们先对变量间的关系进行了初步的可视化分析。为了展示 Y 染色体浓度与孕周（GW）及孕妇 BMI 之间的关系，我们绘制了散点图。在此基础上，我们进一步采用了局部加权散点平滑（LOESS）方法，在散点图上叠加了拟合曲线。LOESS 通过对每个数据点周围的局部数据子集进行加权多项式回归，能够捕捉并展示数据的局部趋势，而无需预设全局的函数形式。

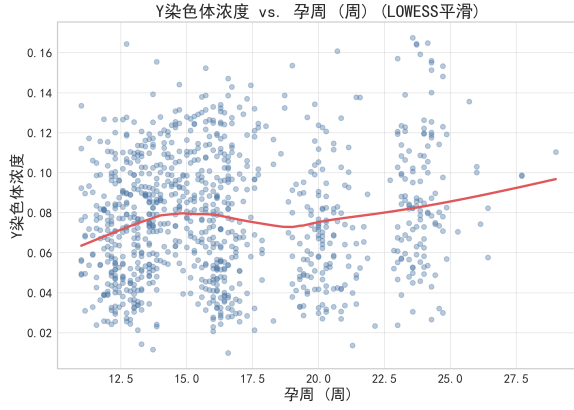


图 12 Y 染色体浓度与孕周的散点关系

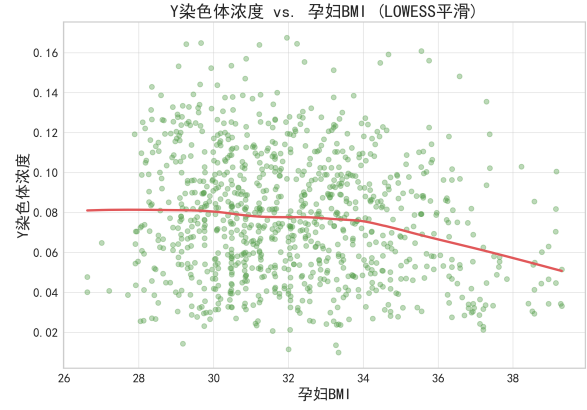


图 13 Y 染色体浓度与 BMI 的散点关系

如图 12 所示，Y 染色体浓度与孕周的关系的平滑曲线呈现出 S 型趋势，表明两者之间存在非线性关系。相比之下，图 13 中 Y 染色体浓度与孕妇 BMI 的散点分布则较为分散。

为对变量间的关联程度进行定量评估，我们还计算了两种相关性度量指标及其对应的统计显著性水平。

皮尔逊相关系数 r 用于衡量两个连续变量间线性关系的强度与方向。其取值范围为 -1 至 1，绝对值越接近 1 表示线性关系越强。计算公式为：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (3)$$

其中 x_i 与 y_i 是第 i 对观测值， $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 分别是两个变量的样本均值， n 是样本总数。皮尔逊 P 值用于检验这种线性相关的统计显著性，表示在原假设即两个变量无线性关系成立的条件下，获得当前或更极端 t 统计量的概率。它通过将相关系数 r 转换为 t 统计量来计算，公式如下：

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad (4)$$

斯皮尔曼相关系数 ρ 则用于度量变量间的单调关系，它不要求变量呈线性关系。该系数同样取值于 -1 至 1 之间。计算时先将原始数据转换为等级，再根据等级计算皮尔逊相关系数，其简化计算公式为：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad (5)$$

此处 d_i 是第 i 对观测值的等级之差。斯皮尔曼 P 值同样用于检验单调关系的显著性，其检验统计量的计算方式与皮尔逊 P 值的类似。

表 2 Y 染色体浓度与核心自变量的相关性分析

变量对	Pearson 相关系数 r	Pearson P 值	Spearman 相关系数 ρ	Spearman P 值
Y 浓度 vs 孕周	0.1087	0.0007	0.0851	0.0083
Y 浓度 vs BMI	-0.1531	0.0000	-0.1321	0.0000

相关性计算的结果如表 2 所示。所有 P 值均远小于 0.01，说明相关性在统计上是显著的。然而，相关系数的绝对值均较小，如 Y 染色体浓度与孕周的皮尔逊相关系数为 0.1087，与 BMI 的相关系数为 -0.1531。这些数值表明变量间的线性关系较弱。定量计算的结果与散点图可视化的结果相符，这进一步说明使用简单的线性模型可能无法充分捕捉变量间的动态关系。

7.2 关系模型的构建与择优

基于探索性分析发现，本文构建了四种不同形式的模型来拟合 Y 染色体浓度与孕周及孕妇 BMI 之间的关系，并通过一系列统计指标对它们的性能进行比较，以选取最合适的模型。

7.2.1 模型构建

模型一为多元线性回归模型，作为后续比较的基准。其形式为：

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 GW_{ij} + \beta_2 BMI_{ij} + e_{ij} \quad (6)$$

模型二为多元多项式回归模型，用以分析之前发现的非线性关系。其形式为：

$$Y_{ij} = \beta_0 + \sum_{k=1}^p \beta_k GW_{ij}^k + \sum_{l=1}^q \gamma_l BMI_{ij}^l + e_{ij} \quad (7)$$

模型三为广义线性模型，它通过对数连接函数处理可能的指数关系。其形式为：

$$g(E[Y_{ij}]) = \beta_0 + \beta_1 GW_{ij} + \beta_2 BMI_{ij} \quad (8)$$

其中 $g(\cdot)$ 为对数连接函数。

模型四为非线性混合效应模型。考虑到数据中包含同一孕妇的多次检测记录，孕妇个体间的生理差异可能对 Y 染色体浓度有影响，为解释这种个体异质性，本文引入了该

模型。该模型在固定效应的基础上，为每个孕妇个体设置了随机效应。其形式为：

$$\begin{aligned}
 Y_{ij} = & \underbrace{(\beta_0 + u_{0i})}_{\text{随机截距}} + \underbrace{\left((\beta_1 + u_{1i})GW_{ij} + \sum_{k=2}^p \beta_k GW_{ij}^k \right)}_{\text{孕周主效应 (含随机斜率)}} \\
 & + \underbrace{\left(\sum_{l=1}^q \gamma_l BMI_{ij}^l \right)}_{\text{BMI 主效应}} + \underbrace{\left(\sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^q \delta_{kl} (GW_{ij}^k \cdot BMI_{ij}^l) \right)}_{\text{多指数交互效应}} + e_{ij}
 \end{aligned} \tag{9}$$

其中， Y_{ij} 表示第 i 位孕妇在第 j 次检测时的 Y 染色体浓度。 GW_{ij} 与 BMI_{ij} 是对应的孕周和身体质量指数。 β_0, β_k 与 γ_l 是固定效应系数，代表了样本总体的平均趋势。 u_{0i} 与 u_{1i} 是随机效应项，分别代表第 i 位孕妇的个体基线水平和对孕周影响的个体差异，它们服从均值为 0 的正态分布。 e_{ij} 是随机误差项。

7.2.2 模型性能评估准则

为在不同形式的模型中进行择优，本文包含多个维度的评估准则，分别从模型拟合度，复杂性惩罚，预测误差和变异解释度四个方面对模型进行评价。

对数似然值，记作 LL，是衡量模型拟合优度的基本指标。它表示在给定模型参数下，观测数据出现的概率的对数。较高的对数似然值说明模型能更好地拟合样本数据。对于一组独立同分布的样本，其计算公式为：

$$LL = \sum_{i=1}^n \ln(f(y_i|\theta)) \tag{10}$$

其中 y_i 是第 i 个观测值， $f(y_i|\theta)$ 是模型在参数 θ 下关于 y_i 的概率密度或概率质量函数， n 为样本量。

赤池信息准则 AIC 与贝叶斯信息准则 BIC 是基于信息论的模型选择标准。它们在对数似然值的基础上，对模型的参数数量施加惩罚，从而在拟合优度与模型简洁性之间进行权衡。数值较小的模型被认为是更优的选择。

$$AIC = 2k - 2LL \tag{11}$$

$$BIC = k \ln(n) - 2LL \tag{12}$$

在上述公式中， k 代表模型中待估参数的个数。BIC 对参数数量的惩罚项 $k \ln(n)$ 比 AIC 的惩罚项 $2k$ 更大，因此 BIC 倾向于选择更为简洁的模型。

均方根误差 RMSE 用于度量模型预测值与真实值之间的偏差大小。它的计算结果与因变量的单位相同，直观反映了模型的平均预测误差。RMSE 的数值越小，表明模型

的预测精度越高。其计算公式为：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (13)$$

此处 y_i 是真实观测值， $\hat{y}_i$ 是模型对第 i 个样本的预测值。

决定系数 R^2 衡量的是模型对因变量方差的解释比例。其取值通常在 0 到 1 之间，越接近 1 说明自变量对因变量的解释能力越强，模型对数据的拟合程度越好。对于普通线性模型，其定义为：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (14)$$

公式中分子的部分是残差平方和，分母的部分是总平方和， $\bar{y}$ 是观测值的样本均值。

对于混合效应模型，决定系数的概念被进一步划分为边际决定系数与条件决定系数，它们分别量化了模型中固定效应部分以及整个模型对因变量变异的解释程度。

边际决定系数 $R_{marginal}^2$ 表示仅由模型中的固定效应解释的方差比例。它反映了群体平均趋势的解释能力。其计算公式为：

$$R_{marginal}^2 = \frac{\sigma_f^2}{\sigma_f^2 + \sigma_r^2 + \sigma_\epsilon^2} \quad (15)$$

在此公式中， σ_f^2 是固定效应预测值的方差， σ_r^2 是随机效应的方差， σ_ϵ^2 是模型残差的方差。

条件决定系数 $R_{conditional}^2$ 表示由固定效应和随机效应共同解释的方差比例。它反映了考虑个体差异后，整个模型的解释能力。其计算公式为：

$$R_{conditional}^2 = \frac{\sigma_f^2 + \sigma_r^2}{\sigma_f^2 + \sigma_r^2 + \sigma_\epsilon^2} \quad (16)$$

该指标在分子中加入了随机效应的方差 σ_r^2 ，因此其值总会大于或等于边际决定系数。这两个指标共同为混合效应模型的性能提供了更全面的评估。

7.3 模型评估结果

表3的评估结果显示，模型一与模型二的调整后决定系数均低于 0.04，说明仅考虑固定效应的线性和多项式模型对 Y 染色体浓度变异的解释能力有限。模型三的伪决定系数为负值，表明该模型的拟合效果差于基础的均值模型。

相比之下，模型四的各项指标均表现出优势。其对数似然值最高，AIC 与 BIC 值最低，说明该模型在拟合优度与模型复杂度之间取得了更好的平衡。模型四的均方根误差 RMSE 为 0.0096，远低于其他模型。该模型提供了两种决定系数，边际 R^2 为 0.4197，代

表 3 四种候选模型的评估指标对比

模型	对数似然值	AIC	BIC	RMSE	R^2
M1 线性回归	1999.22	-3992.43	-3977.82	0.0303	0.0377 ^a
M2 多项式回归	1999.61	-3991.23	-3971.75	0.0303	0.0375 ^a
M3 广义线性模型	2005.10	-4004.20	-6420.10	0.0303	-0.0107 ^b
M4 混合效应模型	2379.25	-4740.50	-4696.68	0.0096	边际: 0.4197, 条件: 0.9158

^a 调整后决定系数

^b 伪决定系数

表仅由固定效应即孕周和 BMI 所解释的变异比例。条件 R^2 为 0.9158，它代表由固定效应和随机效应共同解释的变异比例。这一数值说明，在考虑了孕妇的个体差异后，模型能够解释 Y 染色体浓度超过 91% 的变异。

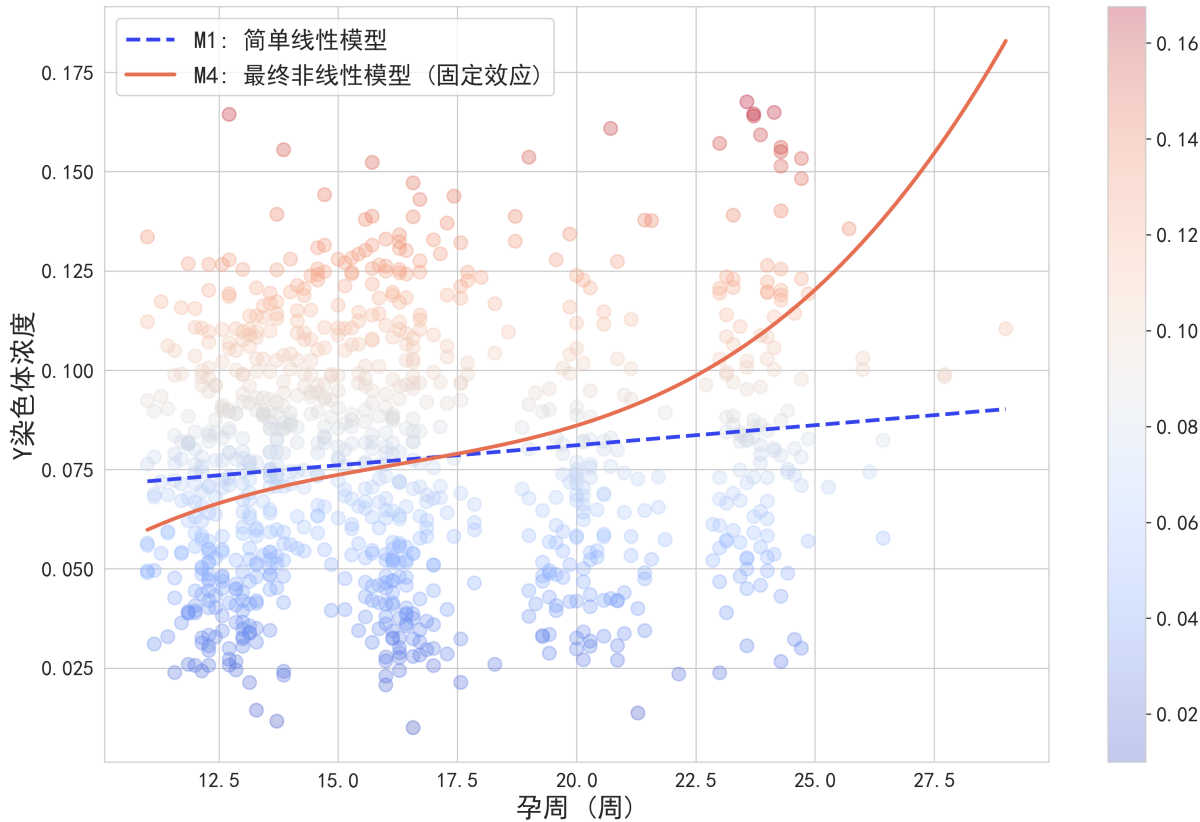


图 14 线性模型与非线性混合效应模型拟合效果对比

图14对比了线性模型与非线性混合效应模型的拟合效果。混合效应模型捕捉到的趋势显然更能贴合数据的整体分布形态。综合各项指标，本文最终选择非线性混合效应模型来描述 Y 染色体浓度与母体指标的关系。

7.4 最终模型解析与显著性检验

在确定采用非线性混合效应模型后，本文通过似然比检验对其具体形式进行了优化。检验结果表明，在模型中加入孕周的二次项能提升模型拟合度，而更高阶的项或交互项则无显著改善。因此，最终确立的模型形式为：

$$\hat{Y}_{ij} = \underbrace{(-0.1135 + u_{0,i})}_{\text{个体基础水平}} + \underbrace{(0.0329 + u_{1,i})}_{\text{个体线性变化率}} \cdot GW_{ij} - 0.00190 \cdot GW_{ij}^2 + 0.0000389 \cdot GW_{ij}^3 - 3.378 \times 10^{-7} \cdot BMI_{ij}^3 \quad (17)$$

其中 Y_{ij} 为因变量， GW_{ij} 与 BMI_{ij} 为自变量， β 系列参数为固定效应系数， u 系列参数为随机效应项。为检验模型中各固定效应的统计显著性，本文对模型的参数估计结果进行分析。

模型参数的评估与检验涉及多个关键指标，它们共同为判断变量效应的显著性与模型的有效性提供依据。

首先是估计系数，记作 $\hat{\beta}$ 。它由模型拟合过程即受限最大似然法得到，其数值是通过最大化样本数据在给定模型结构下的似然函数来确定的。此系数代表了自变量每变化一个单位，对因变量产生的平均效应的量化估计。

其次是标准误差，记作 $SE(\hat{\beta})$ 。它是对估计系数 $\hat{\beta}$ 抽样分布标准差的估计，反映了估计值的精密度。标准误差的数值越小，表明参数估计的确定性越高。其计算源于模型参数的方差协方差矩阵的对角线元素：

$$SE(\hat{\beta}_k) = \sqrt{Var(\hat{\beta}_k)} \quad (18)$$

其中 $Var(\hat{\beta}_k)$ 表示第 k 个估计系数 $\hat{\beta}_k$ 的方差。

为进行假设检验，需要计算 z 统计量。该统计量衡量估计系数偏离原假设零值的标准误差倍数，其意义在于将估计系数的差异标准化，以便于进行统计推断。计算公式为：

$$z = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})} \quad (19)$$

在此公式中， β_0 是原假设下的参数值，通常设为零以检验变量的效应是否显著。

根据 z 统计量可以计算出 P 值。它是在原假设即系数为零成立的前提下，观测到当前或更极端统计量的概率。 P 值越小，表明观测结果越不可能由随机抽样误差造成的，拒绝原假设的理由越充分。对于双侧检验，其计算公式为：

$$P = 2 \cdot \Phi(-|z|) \quad (20)$$

其中 Φ 是标准正态分布的累积分布函数， $|z|$ 是 z 统计量的绝对值。

最终模型的固定效应参数估计与检验结果如下表所示。

表 4 最终模型固定效应参数估计与检验

固定效应	估计系数	z 统计量	P 值
截距	-0.1135	-2.479	0.013
孕周	0.0329	4.162	<0.001
孕周二次项	-0.0019	-4.247	<0.001
孕周三次项	3.89e-05	4.772	<0.001
BMI 三次项	-3.38e-07	-1.800	0.072

表4的参数估计结果揭示了各变量对 Y 染色体浓度的具体影响。孕周的线性，二次项与三次项的 P 值均远小于 0.001，表明这些效应在统计上是极端显著的。这些系数共同作用，构成了 Y 染色体浓度随孕周变化的 S 型曲线关系。孕妇 BMI 三次项的 P 值为 0.072，处于统计学上的边缘显著水平，说明其对 Y 染色体浓度的影响相对微弱。

表 5 最终模型决定系数

指标	值
边际 R^2	0.4197
条件 R^2	0.9158

模型的決定系数分解结果为理解变异来源提供了定量证据，见表5。边际 R^2 为 0.4197，这表明由孕周和 BMI 构成的固定效应，即所有孕妇共有的普遍规律，能够解释 Y 染色体浓度总体变异的 41.97%。条件 R^2 的值为 0.9158，这意味着当模型同时考虑普遍规律和个体差异即随机效应后，其对总体变异的解释能力上升至 91.58%。

两者之差，即 91.58% 减去 41.97% 等于 49.61%，这部分变异由不可观测的孕妇个体特异性所解释。个体差异即随机效应的影响程度 49.61%，超过了所有可观测变量即固定效应的总和 41.97%。这一结果表明，个体差异是 Y 染色体浓度变异的主导因素。模型的方差成分进一步量化了这种差异，其中随机截距的方差为 1.627e-03，随机斜率的方差为 6.682e-06。

图15是最终模型结果的可视化呈现，是问题一的核心结论。图中的红色粗线代表了由固定效应决定的总体平均趋势，即所有孕妇共有的 S 型变化规律。大量的蓝色细虚线则代表了考虑随机效应后，每一位孕妇个体的实际拟合轨迹，直观展现了巨大的个体差异。

综合来看，Y 染色体浓度的变化遵循一个由孕周主导的 S 型非线性变化，这一趋势具有统计学意义。然而，该规律在不同孕妇间的表现存在显著的差异性，个体差异性是

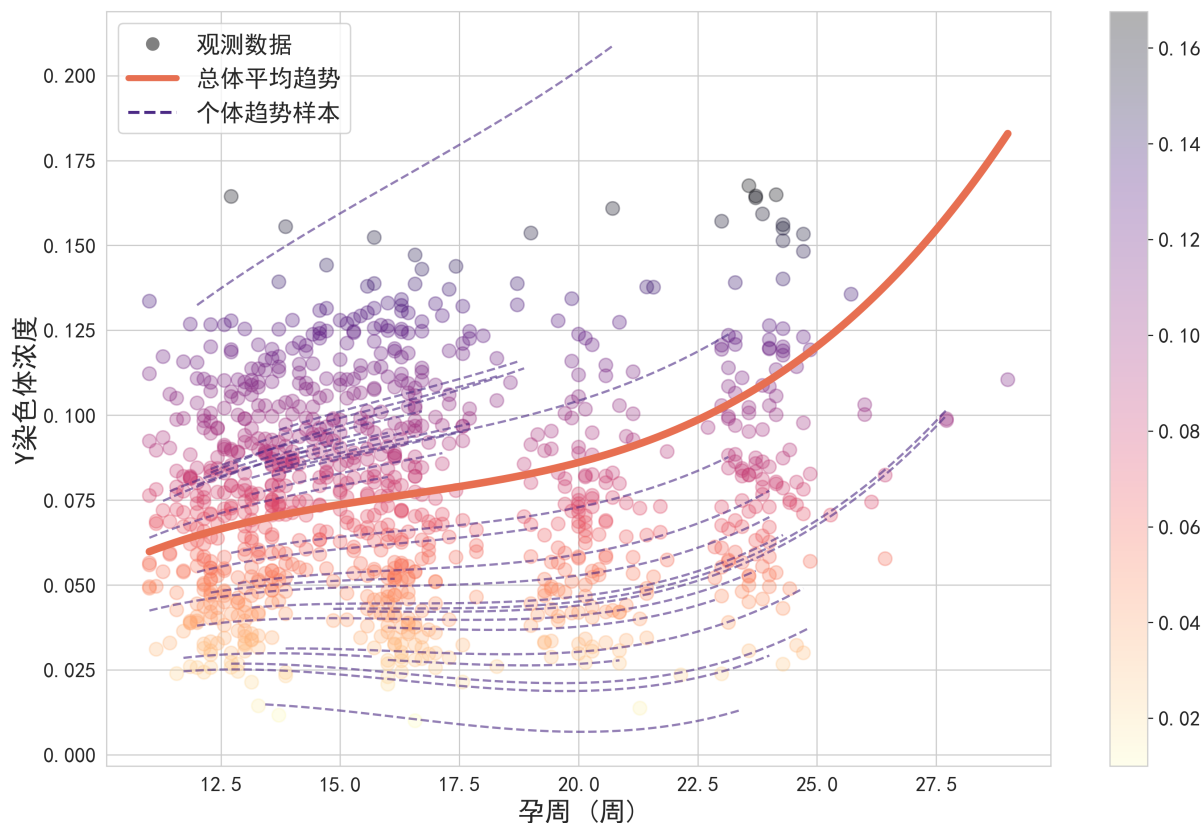


图 15 最终模型揭示的总体趋势与个体差异

引起浓度变化的更主要来源。相比之下，孕妇的 BMI 在此模型中仅表现出边缘显著的微弱影响。

八、问题二：分组优化与 NIPT 时点决策模型

问题二要求为不同身体质量指数即 BMI 的男胎孕妇制定分组方案，并为各组确定唯一的最佳 NIPT 检测时点。该策略的目标是最小化全体孕妇的潜在风险总和。决策过程需要在两种风险之间权衡，一是过早检测可能因 Y 染色体浓度不达标而失败，二是过晚检测会缩短临床干预的有效时间。为处理此权衡问题，本文建立了一个包含孕妇分组与时点选择的双层决策模型。具体机制如图 16 所示。

8.1 风险量化与目标函数构建

本模型不直接预测每位孕妇 Y 染色体浓度达标的具体时间，而是采用检测失败概率来量化不确定性。模型的优化目标是最小化所有孕妇群体的加权风险总和。对于任一分组，其总期望风险由过晚检测风险与检测失败风险两部分构成。

过晚检测风险的量化依据题目描述的孕期风险等级。本文构建了一个分段函数来描述风险随时间非线性增长的特性。该函数在早期阶段为线性增长，在中期阶段增速加



图 16 问题二流程图

快，在晚期阶段则呈指数增长，其数学表达式为：

$$R_{late}(t_i) = \begin{cases} \frac{2}{14}(t_i - 70) & \text{若 } 70 \leq t_i \leq 84 \\ 2 + \frac{4}{105}(t_i - 84) & \text{若 } 84 < t_i \leq 189 \\ 0.2225 \cdot e^{0.0243 \cdot t_i} & \text{若 } 189 < t_i \leq 210 \end{cases} \quad (21)$$

其中， t_i 代表以天为单位的检测时点， $R_{late}(t_i)$ 是对应的累积健康风险值。

检测失败风险的量化引入了微观经济学中的机会成本理论。在某一时间点进行检测若失败，将导致必须推迟至下一时间点才能再次检测。此时间延迟期间，孕妇需承受额外的健康风险增量，这构成了检测失败的机会成本。因此，检测失败风险被定义为期望失败概率与该机会成本的乘积，其数学表达式为：

$$R_{fail}(t_i) = E[P_{fail,group}(t_i)] \times W(t_i) \times [R_{late}(t_i + \Delta t) - R_{late}(t_i)] \quad (22)$$

式中 $E[P_{fail,group}(t_i)]$ 为分组在时点 t_i 的期望失败概率， Δt 为两次检测的固定时间间隔，本文设定为 14 天。 $W(t_i)$ 是一个随时间变化的价值权重函数，用于体现不同孕周下决策价值的差异。该函数为一个反向逻辑斯谛函数，其形式如下：

$$W(t_i) = 0.01728 + \frac{0.16344}{1 + e^{0.1(t_i - 154)}} \quad (23)$$

其中变量 t_i 为检测时点的天数。

综合上述两种风险，任意分组 i 在特定检测时点 t_i 的总期望风险 $R_i(t_i)$ 为

$$R_i(t_i) = R_{late}(t_i) + R_{fail}(t_i) \quad (24)$$

寻找使此总风险最小的时点 t_i^* 是模型求解的核心环节之一。

8.2 孕妇分组与失败概率预测

为对孕妇进行合理分组，本文采用 K 均值聚类算法。该算法依据数据样本在特征空间中的分布，将所有样本划分为 K 个类别。其基本原理是通过迭代过程，寻找 K 个聚类中心，使得每个样本点到其所属聚类中心的距离平方和达到最小。本文中，该算法被应用于对孕妇的 BMI 值进行分组。

为计算特定分组在特定时间的期望失败概率，需要一个能够预测 Y 染色体浓度的数学模型。本文沿用问题一中建立的非线性混合效应模型，该模型能同时反映群体平均趋势与个体生理差异。模型形式为：

$$\hat{Y}_{ij} = (\beta_0 + u_{0,i}) + (\beta_1 + u_{1,i})\text{GW}_{ij} + \beta_2\text{GW}_{ij}^2 + \beta_3\text{GW}_{ij}^3 + \beta_4\text{BMI}_{ij}^3 \quad (25)$$

其中 $\hat{Y}_{ij}$ 是对第 i 位孕妇在第 j 次检测时 Y 染色体浓度的预测值。基于此模型，可以计算出任一孕妇 i 在未来时间点 t 的检测失败概率。检测失败被定义为 Y 染色体浓度低于 4% 的阈值。个体失败概率 $P_{fail,i}(t)$ 的计算式为：

$$P_{fail,i}(t) = P(Y_i(t) < 0.04) = \Phi\left(\frac{0.04 - \hat{Y}_i(t)}{\hat{\sigma}_\epsilon}\right) \quad (26)$$

其中 $\Phi(\cdot)$ 是标准正态分布的累积分布函数， $\hat{\sigma}_\epsilon$ 是模型残差的标准差。一个分组的整体期望失败概率，通过对该组内所有个体失败概率取算术平均值得到：

$$E[P_{fail,group}(t)] = \frac{1}{n_{group}} \sum_{i \in group} P_{fail,i}(t) \quad (27)$$

此处的 n_{group} 是该分组内的孕妇总人数。混合效应模型为部分孕妇生成的 Y 染色体浓度达标概率预测曲线如图 17 所示，图中轨迹的差异性体现了模型对个体差异的捕捉。

8.3 优化模型求解与最优方案确定

本文构建的优化模型旨在寻找最优的分组数量 K 与各组对应的最佳检测时点 t_i ，以实现所有孕妇加权平均总风险的最小化。其统一的数学形式如下：

决策变量为分组数 K 和各组的检测时点 t_i 。

目标函数为最小化加权平均总风险 $E[R_{total}]$

$$\min_{K, \{t_i\}} E[R_{total}] = \sum_{i=1}^K \frac{n_i}{N} \cdot R_i^*(t_i^*) \quad (28)$$

其中 N 为孕妇总数， n_i 为第 i 组的人数， $R_i^*(t_i^*)$ 是第 i 组在其最优检测时点 t_i^* 下的最小期望风险。

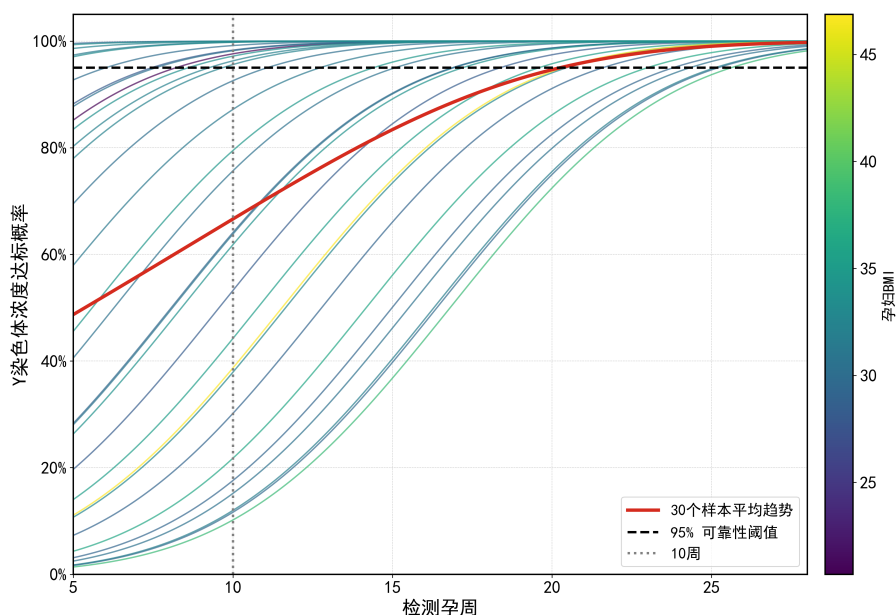


图 17 混合效应模型预测的个体 Y 染色体浓度达标概率变化轨迹

约束条件为所有检测时点 t_i 均需在 70 天至 196 天的可行时间范围内。

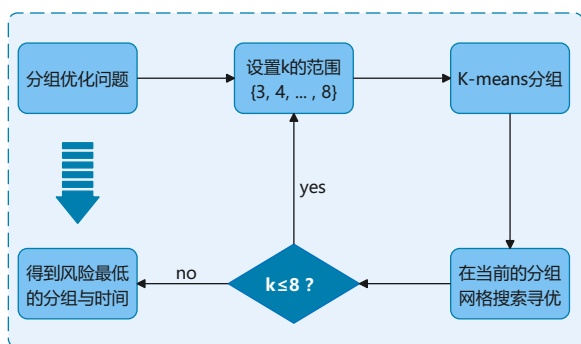


图 18 双层优化算法

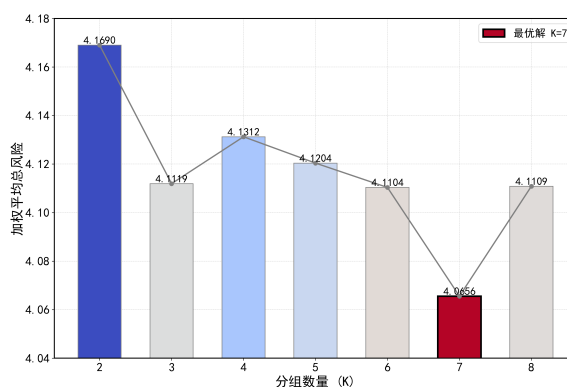


图 19 不同分组数 K 对应的加权平均总风险

模型的求解采用双层优化算法，具体机制如图 18 所示。外层循环遍历不同的分组数 K ，本文设定 K 的取值范围为 2 至 8。对于每一个 K 值，首先应用 K 均值聚类算法对所有样本的 BMI 进行分组。随后，在内层优化中，对每一个组别采用网格搜索法。在 70 天至 196 天的时间范围内，逐日计算该组的总期望风险值，并将风险最低点对应的时间确定为该组的最佳 NIPT 时点。完成所有组别的时点优化后，计算当前 K 值下的加权平均总风险。最后，通过比较不同 K 值对应的加权平均总风险，选取风险最低的方案作为最终结果。

不同分组数 K 对应的加权平均总风险值比较见图 19。计算结果表明，当分组数 K 等于 7 时，加权平均总风险达到所有候选方案中的最小值 4.0656。因此，将孕妇群体划分为七个组别是当前模型下的最优策略。

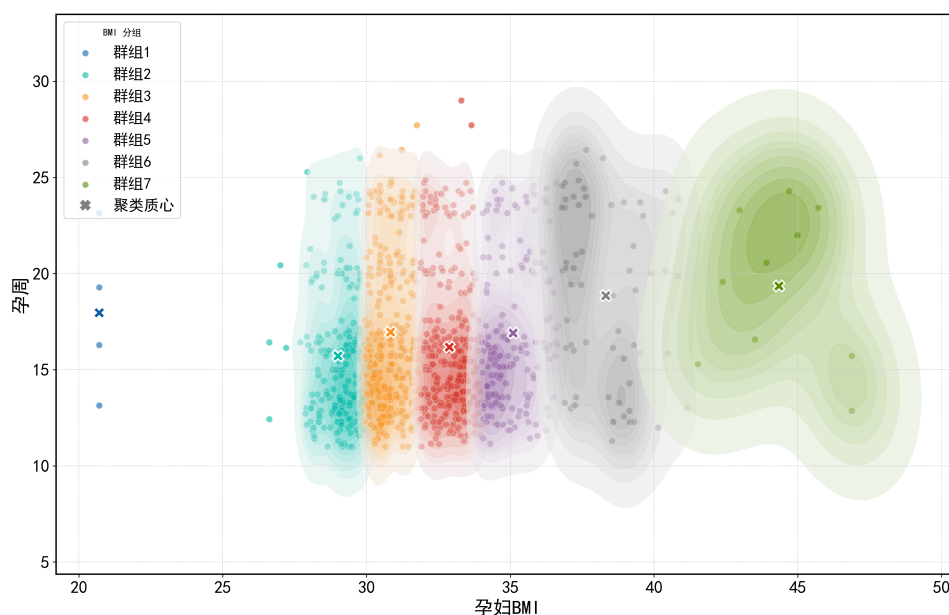


图 20 最优分组数 K 等于 7 时基于 BMI 的聚类结果

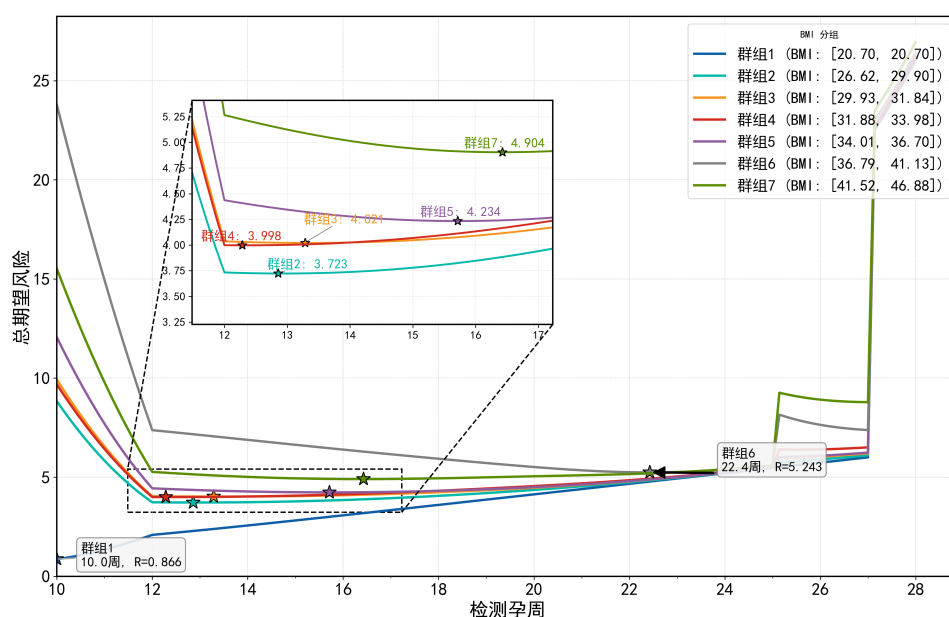


图 21 最优分组方案下各群组的期望风险曲线

在最优分组数确定为 7 后，对孕妇 BMI 进行聚类的结果如图 20 所示。图中每个样本点根据其所属群组被赋予不同颜色，七个群组沿孕妇 BMI 轴向分布，形成了七个相互邻接的区间。

各群组的最佳检测时点由其总期望风险曲线确定，如图 21 所示。图中每条曲线代表一个 BMI 群组的总期望风险随检测孕周的变化。所有曲线初期均呈现下降趋势，之后转为上升，曲线的最低点即为该群组风险最小化的最佳检测时点。一个主要趋势是，随着孕妇 BMI 的升高，风险曲线的最低点向更晚的孕周移动。

最终的分组方案与各组别的最佳 NIPT 时点建议在表 6 中进行了总结。该表列出了

表 6 最优分组方案与 NIPT 时点建议

群组	BMI 范围	孕妇数量	最佳时点 (周)
群组 1	[20.70, 20.70]	4	10.0
群组 2	[26.62, 29.90]	197	12.86
群组 3	[29.93, 31.84]	300	13.29
群组 4	[31.88, 33.98]	260	12.29
群组 5	[34.01, 36.70]	163	15.71
群组 6	[36.79, 41.13]	64	22.43
群组 7	[41.52, 46.88]	10	16.43

每个群组的 BMI 取值范围与孕妇数量。核心结果为最佳检测时点，数据显示 BMI 与最佳时点存在正向关联趋势。BMI 最低的群组其最佳检测时点为孕 10 周，而 BMI 较高的群组其最佳检测时点则推迟至孕 22.43 周。

8.4 模型稳定性分析

为检验决策模型结论的稳定性，本文评估了关键参数变动对最优 NIPT 时点选择的影响，分别分析了机会成本函数中的时间延迟参数以及 Y 染色体浓度检测阈值这两个要素。

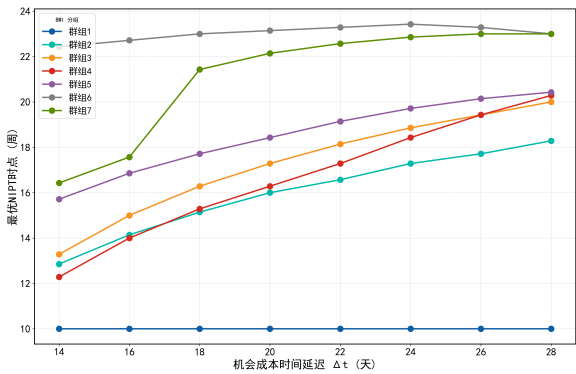


图 22 机会成本时间延迟 Δt 的敏感性分析

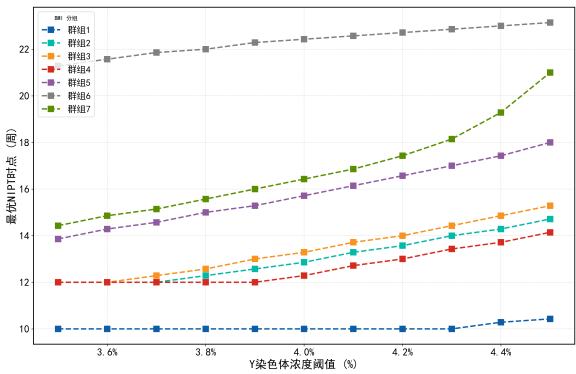


图 23 Y 染色体浓度阈值对最佳检测时点的影响分析

在风险量化模型中，机会成本的计算涉及时间延迟参数 Δt 。为探究模型对该参数的敏感程度，我们将 Δt 的取值在 14 天至 28 天之间进行遍历，并为每个取值重新计算所有分组的最优 NIPT 检测时点。分析结果如图 22 所示，图中显示，随着时间延迟参数 Δt 的增加，多数群组的最佳检测时点均向更早的孕周移动。这是因为时间延迟的增加意味着检测失败将导致更高的机会成本，决策模型会选择一个更早的检测时间点以降低发生失败的可能性。

NIPT 检测的成功与否取决于 Y 染色体浓度是否达到临床标准阈值。为评估最优时点策略对此标准变化的依赖性，我们将浓度阈值在 3.5% 至 4.5% 的区间内进行变动。在每个设定的阈值水平下，我们都重新运行完整的时点优化流程。图 23 展示了各分组的最佳检测时点随浓度阈值变化的趋势。结果表明，当检测标准变得更为严格即浓度阈值提高时，所有分组的最佳检测时点均一致性地向后推迟。这是因为模型需要通过延长等待时间来确保胎儿的 Y 染色体浓度有更大概率生长至新的更高标准之上。

九、 问题三：多因素约束下的 NIPT 时点优化决策

问题三的目标是综合孕妇的身高、体重、年龄与身体质量指数 BMI 等多种因素，在满足特定 Y 染色体浓度达标比例的前提下，为通过 BMI 划分的不同孕妇群体制定风险最小化的最优 NIPT 检测时点。为达成此目标，本文构建了一个职责分离的建模框架。该框架首先利用全体样本数据进行客观的孕妇分群，随后在提纯后的高质量数据子集上训练一个包含多因素的稳健预测模型，最终将分群与预测结果结合，通过带约束的多目标优化方法求解各群组的最优检测策略。具体流程如图24所示。

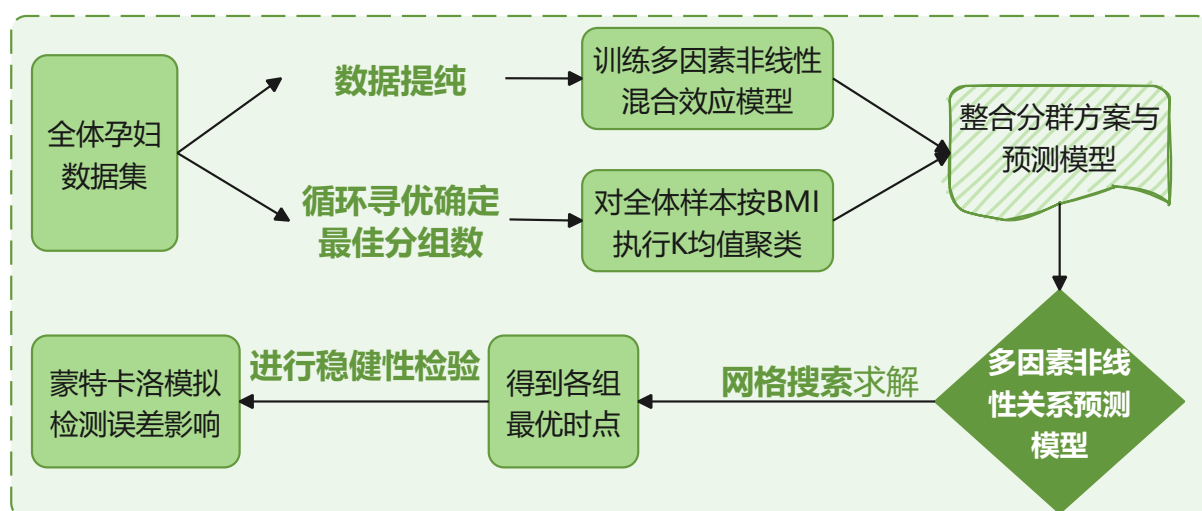


图 24 问题三的建模框架

9.1 基于全体样本的孕妇分群

为保证分群的普适性，分群过程在包含全部 998 条记录的完整数据集上进行。依据题目的要求，我们仅使用孕妇 BMI 这单一维度特征作为分组依据。本文选择 K 均值聚类算法对全体孕妇进行分组。

最优分组数量 K 的选择，是基于最终优化目标的反馈来决定的。本文遍历不同的分组数量 K，从 2 至 8。对每一种 K 值下的分组方案，都执行后续的完整优化流程，计算

出该方案对应的全体孕妇的加权平均总风险。最终选择使该全局风险指标最小的 K 值，作为最优的分组数量。

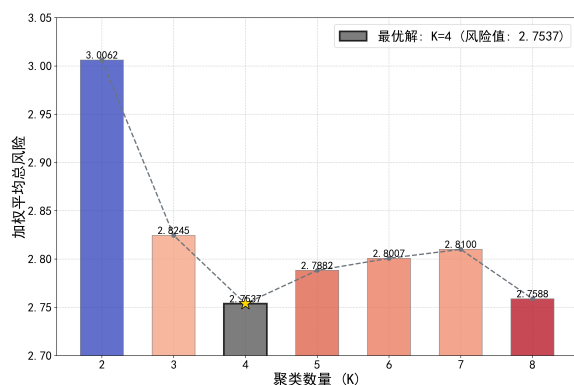


图 25 基于总风险最小化的最优分组数决策

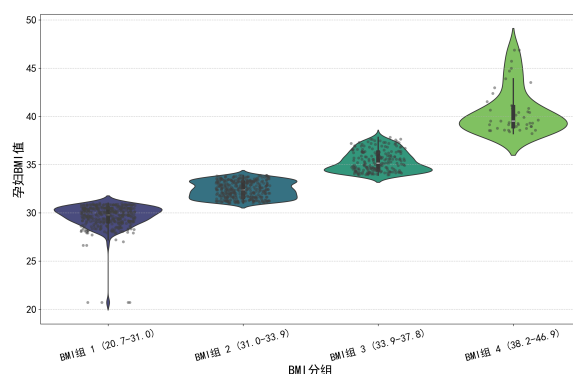


图 26 最优分组数 K 等于 4 时的 BMI 聚类结果

表 7 对各模型在测试集上的性能指标进行了量化总结。数据显示，决策树模型虽然获得了最高的异常类召回率 0.6316，但其精确率仅为 0.2034，是三者中最低的，这表明该模型倾向于将大量正常样本误判为异常。相比之下，逻辑回归模型在各项指标上表现出更优的综合性能：其异常类 F1 分数 0.4390 和 AUC 值 0.8045 均为最高，这意味着它在精确率和召回率之间取得了最优的平衡，且整体判别能力最强。尽管 XGBoost 的精确率略高于逻辑回归，但其召回率过低，导致 F1 分数不理想。综合考量，逻辑回归模型因其平衡性和整体性能，被选定为最终的判定模型。

不同 K 值对应的加权平均总风险计算结果展示于图 25。图中横坐标为聚类数量 K，纵坐标为加权平均总风险。曲线显示，当分组数 K 等于 4 时，总风险达到所有候选方案中的最低点。因此，本文最终确定 K 等于 4 为最优分组数。

依据最优分组数 4，K 均值聚类算法在全体样本上的划分结果如图 26 所示。该图展示了四个沿身体质量指数分布的孕妇群组。最终确定的四个群组及其身体质量指数范围分别为：组 1，范围 20.7 至 31.0；组 2，范围 31.0 至 33.9；组 3，范围 33.9 至 37.8；组 4，范围 38.2 至 46.9。

9.2 多因素非线性关系预测模型

为建立一个能预测 Y 染色体浓度的模型，并减弱离群点对模型参数估计的干扰，本阶段先进行数据处理。从完整的 998 条记录出发，对孕周，身高，体重，年龄，孕妇身体质量指数与 Y 染色体浓度六个核心变量，逐一应用 1.5 倍四分位距准则进行离群点检测。该过程形成了一个包含 931 条观测记录的数据集，用于后续预测模型的训练。

模型类型上，本文选择非线性混合效应模型，以捕捉变量间的非线性关系以及孕妇间的个体差异。同时，为模拟真实检测中存在的随机波动，模型中加入了代表检测误差

的高斯噪声项。根据在处理后的数据集上的拟合结果，最终确立的预测模型表达式为：

$$\begin{aligned}
\hat{Y}_{ij} = & u_{0,i} - 7.1472 \\
& + 4.5615 \times 10^{-3} \cdot \text{孕天数}_{ij} - 3.4421 \times 10^{-5} \cdot \text{孕天数}_{ij}^2 + 9.5710 \times 10^{-8} \cdot \text{孕天数}_{ij}^3 \\
& + 0.1274 \cdot \text{BMI}_{ij} - 9.7171 \times 10^{-4} \cdot \text{BMI}_{ij}^2 \\
& + 5.9349 \times 10^{-3} \cdot \text{年龄}_{ij} - 8.5600 \times 10^{-5} \cdot \text{年龄}_{ij}^2 \\
& - 0.0449 \cdot \text{体重}_{ij} + 1.1372 \times 10^{-4} \cdot \text{体重}_{ij}^2 \\
& + 0.0581 \cdot \text{身高}_{ij} - 9.8937 \times 10^{-5} \cdot \text{身高}_{ij}^2 \\
& + 9.1773 \times 10^{-6} \cdot (\text{孕天数}_{ij} \times \text{孕妇 BMI}_{ij}) \\
& - 1.6636 \times 10^{-5} \cdot (\text{孕天数}_{ij} \times \text{年龄}_{ij}) \\
& + \epsilon
\end{aligned} \tag{29}$$

其中， $u_{0,i}$ 是第 i 位孕妇的随机效应截距，代表了个体特异性，其服从均值为 0，方差为 6.965×10^{-4} 的正态分布，即 $u_{0,i} \sim \mathcal{N}(0, 6.965 \times 10^{-4})$ 。 ϵ 代表检测误差，服从均值为 0 的正态分布， $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{error}^2)$ 。

9.3 带约束的时点优化与稳健性检验

本阶段将分组结果与预测模型整合，以求解各组的最优检测时点。优化模型的目标函数为最小化总期望风险 $R_{total}(t_g)$ 。模型中的关键指标推导如下。基于非线性混合效应模型的预测值 $\hat{Y}_i(t)$ 与残差标准差 $\hat{\sigma}_{residual}$ ，可计算任一孕妇在时间点 t 的个体达标概率：

$$P_{\text{pass},i}(t) = 1 - \Phi \left(\frac{0.04 - \hat{Y}_i(t)}{\hat{\sigma}_{residual}} \right) \tag{30}$$

一个群组 g 的群体期望达标比例，定义为该组内所有个体达标概率的算术平均值：

$$P_{\text{rate}}(t_g) = \frac{1}{|I_g|} \sum_{i \in \text{group}_g} P_{\text{pass},i}(t) \tag{31}$$

总期望风险 $R_{total}(t)$ 则由延迟检测的健康风险 $R_{late}(t)$ 与检测失败的机会成本风险 $R_{fail}(t)$ 两部分构成：

$$R_{\text{total}}(t) = R_{late}(t) + R_{fail}(t) \tag{32}$$

求解过程采用网格搜索算法，在 70 天至 196 天的时间范围内，为每个群组寻找最优时点。

为检验模型结论在面对现实检测误差时的稳健性，本文进行了敏感性分析。通过蒙特卡洛模拟，在非线性混合效应模型的预测值上，叠加一个服从均值为 0，标准差为

σ_{error} 的正态分布随机误差。

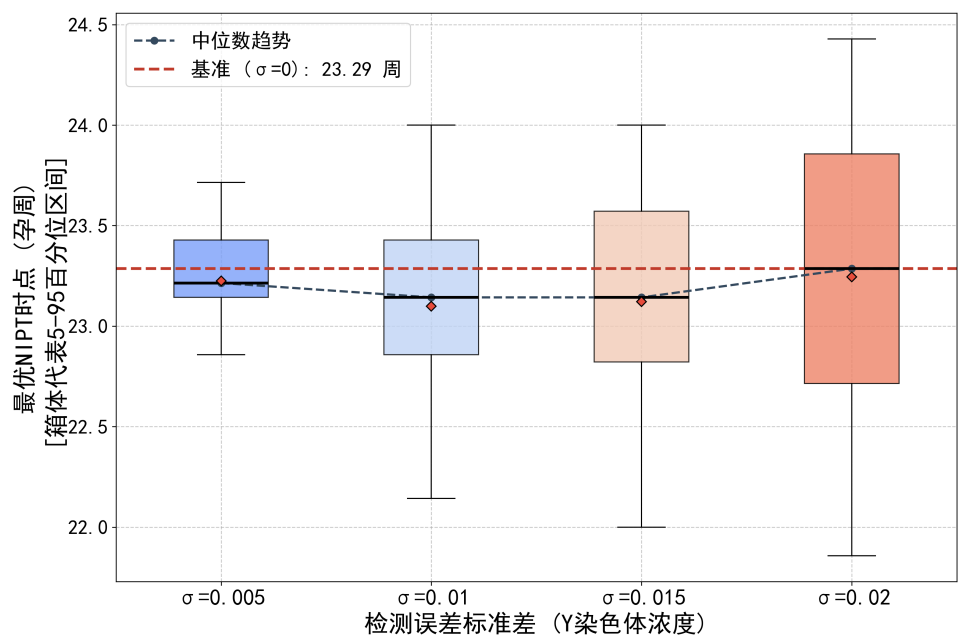


图 27 最优时点对检测误差的敏感性分析

图 27 中的箱线图展示了 BMI 最高的组 4，在期望达标比例为 92.5% 的约束下，随着检测误差标准差 σ_{error} 从 0.0 增大到 0.015，最优时点分布的变化。结果显示，随着检测误差的增大，推荐的最优时点均值保持稳定，但分布的离散程度显著增加。这表明本决策框架具有良好的稳健性，即使存在一定的检测误差，推荐的最佳时点均值也不会发生剧烈偏移，保证了决策建议的可靠性。

十、问题四：女胎异常判定模型的建立

为对女胎染色体异常情况进行判定，本文建立并评估了多种机器学习模型。我们对不平衡数据进行处理后，采用了多种机器学习分类算法训练分类模型。然后通过一系列评价指标进行评估，最后基于分类模型给出了女胎异常的判定方法。具体流程如图 28 所示。

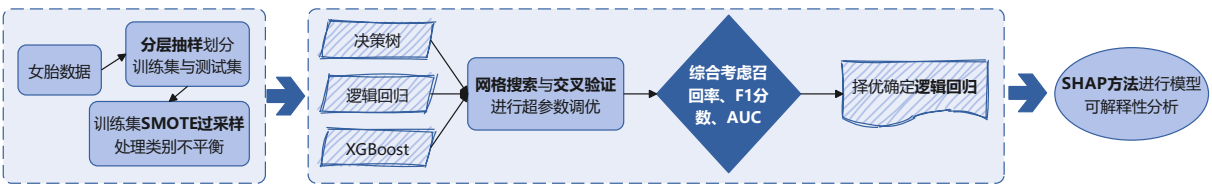


图 28 问题四的建模框架

10.1 模型准备与评估方法

10.1.1 数据集划分与不平衡处理

为训练分类模型，我们首先将模型准备部分处理好的女胎检测数据按照 7 比 3 的比例进行分层抽样，分别作为训练集与测试集。分层操作确保了两个数据子集中的异常样本比例与原始数据集保持一致。

在模型准备部分，我们发现数据集中正常与异常样本比例约为 9 比 1，两种类别的数据量极度不平衡。如果直接使用不平衡的数据来训练分类模型，会使得模型更多关注于占比较大的那一类的特征，导致模型对少数类的识别能力较差。

为应对此类问题，我们采用 SMOTE 算法对训练集数据中的少数类别数据进行过采样，该技术通过在少数类样本附近合成新的样本来增加其数量，因此可以生成新的数据，而不是简单地复制数据。我们将训练数据中原本的比例由约 1 比 9 提升至 1 比 2。这种采样比例的设计可以在增强模型对少数类别学习能力的同时，避免因引入过多人工样本而可能出现的过拟合现象。同时，为了保证测试集的测试作用，我们未对测试集数据进行过采样处理。

10.1.2 分类模型介绍

综合考虑女胎检测数据的数据量大小和特征数量，我们选取了逻辑回归、决策树与 XGBoost 三种分类算法进行训练与比较。

逻辑回归是一种用于处理二元分类问题的统计方法。该模型通过 sigmoid 函数，将自变量的线性组合映射到 0 至 1 的区间内，所得到的数值可以被解释为某个事件发生的概率。对于给定的输入特征向量 X ，其属于正类的概率 $p(X)$ 的计算方式为：

$$p(X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i X_i)}} \quad (33)$$

在此式中， β_0 是截距项， β_i 是第 i 个特征 X_i 对应的模型系数。当模型输出的概率值大于预设的阈值，一般为 0.5 时，样本被判定为正类，反之则为负类。

决策树是一种基于树状结构进行决策的非参数学习算法。该模型通过从数据中学习一系列分层的是非问题来对样本进行分类。整个模型的结构形似一棵倒置的树，其中每个内部节点代表对一个特征属性的测试，从该节点引出的每个分支代表测试的一个可能结果，而每个叶节点则代表一个最终的类别标签。决策树是典型的白盒模型，具有可解释性强、训练速度快的优点。

XGBoost 是梯度提升框架下的一种算法实现。它属于集成学习方法，通过迭代式地生成一系列弱学习器，如决策树，并将它们组合起来形成一个表现更好的学习模型。该算法以序列化的方式构建模型，在每一轮迭代中，一个新的决策树被训练出来，其目标是修正前面所有树组成的集成模型所犯的误差。具体而言，新的树拟合的是损失函数关

于前一轮模型预测结果的负梯度，即残差。第 t 轮迭代后，对样本 x_i 的预测值 $\hat{y}_i^{(t)}$ 由前一轮的预测值与当前轮新加入的树模型 $f_t(x_i)$ 共同构成

$$\hat{y}_i^{(t)} = \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(x_i) \quad (34)$$

最终的预测结果是所有轮次生成的树模型输出值的总和。该方法在损失函数中加入了正则化项，用以控制模型的复杂度，从而防止过拟合。

10.1.3 模型优化与评估指标

为使各模型达到其最优状态，采用**网格搜索**与**交叉验证**相结合的方法进行超参数调优，使得三种模型在训练集数据下达到最佳的分类效果。

在数据类别不平衡的场景下，漏掉一个少数类样本的代价远高于将多数类样本误判。召回率这一指标直接衡量模型找出所有少数类样本的能力。因此，我们选择召回率为优化目标，取 5 折分层交叉验证进行三个分类模型的调优。

10.2 模型性能比较分析

在模型调优完成后，我们在测试集上通过多个指标对三个模型进行全面评估，并选择最终模型。根据前面的分析，评估的首要指标是异常类别的召回率，这个指标可以直接体现分类模型对于少数类别样本的识别能力。当召回率相近时，则依次比较 F1 分数、AUC 值以及精确率。

经过计算，我们得到了三个模型最优参数下的分类性能指标。图 29 展示了三个模型在不同阈值设定下区分正常与异常样本的整体能力。图中曲线如果越靠近左上角，则其下方的面积即 AUC 值越大，说明模型的判别能力越高。逻辑回归模型的 ROC 曲线 AUC 值为 0.805，优于决策树的 0.671 和 XGBoost 的 0.692，表明其在所有阈值下的判别能力相对更优。

图 30 是三个分类模型的混淆矩阵，展示了各模型在测试集上的预测结果分布。测试集中共包含 19 例异常样本和 140 例正常样本。从结果可以看出，三个模型对正常样本的预测性能都比较好。而对于异常样本的预测，逻辑回归与决策树均成功识别出其中的 9 例，对应 10 例漏诊，两者的召回率均为 47.4 百分比。XGBoost 模型仅识别出 5 例，漏诊 14 例。在误诊方面，逻辑回归将 13 例正常样本错误判断为异常，而决策树的误诊数量为 28 例。此结果表明，对于我们主要关注的胎儿异常样本，逻辑回归的查准能力更优。

表 7 对各模型在测试集上的性能指标进行了量化总结。数据显示，决策树模型虽然获得了最高的异常类召回率 0.6316，但其精确率仅为 0.2034，是三者中最低的，这表明该模型倾向于将大量正常样本误判为异常。相比之下，逻辑回归模型在各项指标上表现

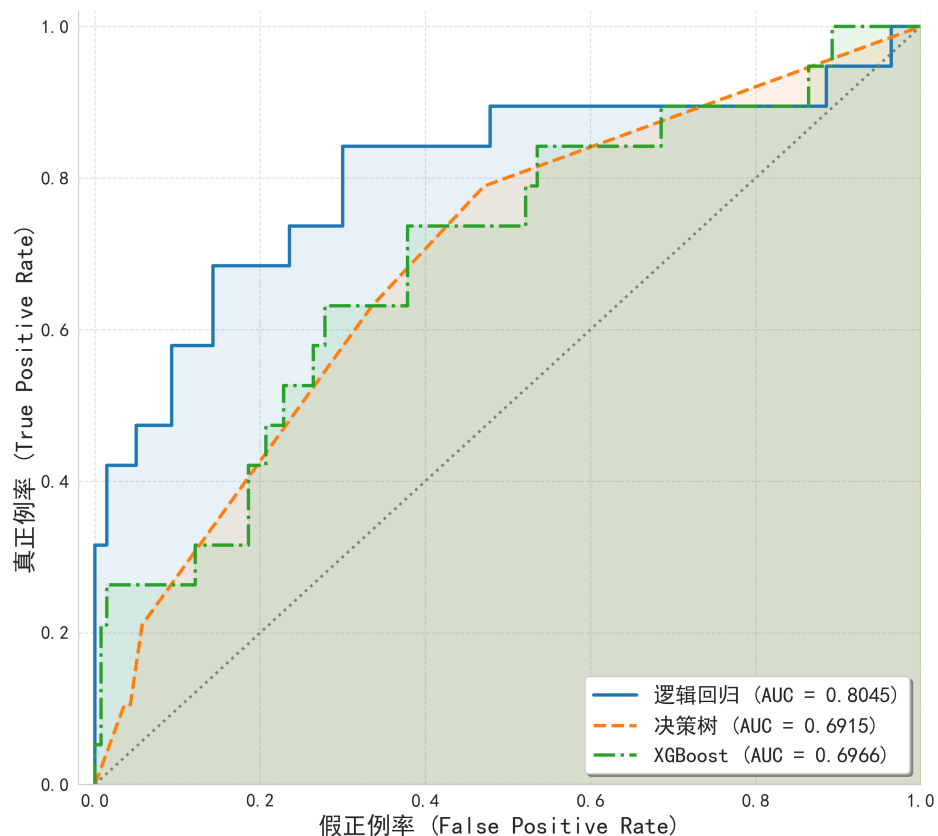


图 29 模型 ROC 曲线对比

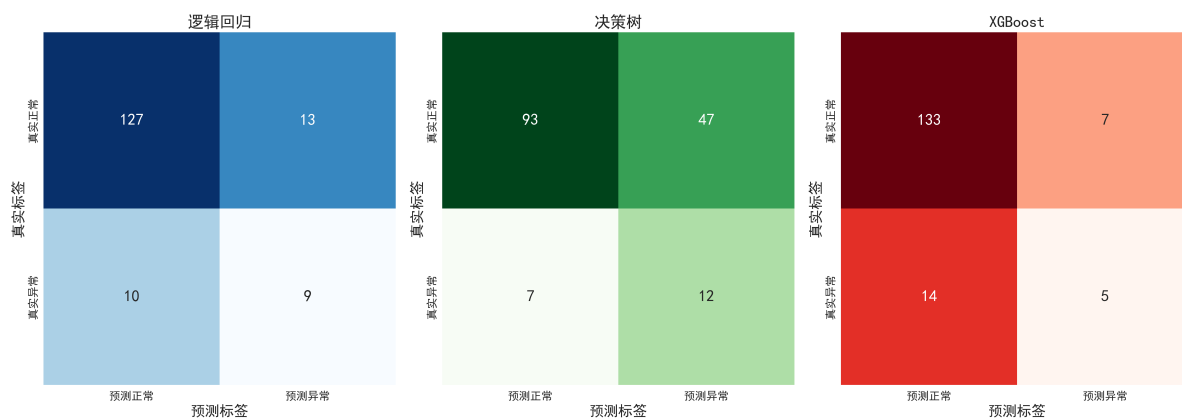


图 30 模型混淆矩阵对比

表 7 各候选模型在测试集上的性能指标对比

模型名称	异常类精确率	异常类召回率	异常类 F1 分数	AUC
逻辑回归	0.4091	0.4737	0.4390	0.8045
决策树	0.2034	0.6316	0.3077	0.6915
XGBoost	0.4167	0.2632	0.3226	0.6966

出更优的综合性能：其异常类 F1 分数 0.4390 和 AUC 值 0.8045 均为最高，这意味着它在精确率和召回率之间取得了最优的平衡，且整体判别能力最强。尽管 XGBoost 的精确率略高于逻辑回归，但其召回率过低，导致 F1 分数不理想。综合考量，逻辑回归模型因其平衡性和整体性能，被选定为最终的判定模型。

10.3 女胎异常的判定方法分析

10.3.1 SHAP 解释性增强原理

逻辑回归模型本身具有一定的可解释性，为得到判定女胎异常的具体依据，我们选择结合 SHAP 方法进行模型解释。SHAP 方法建立在合作博弈论中的夏普利值理论之上，为机器学习模型的预测结果提供解释。其核心思想是将数据样本的每一个特征视为参与一场合作的成员，而最终回报即为模型的预测输出。对于单个预测样本，SHAP 值能够计算出每个特征在所有可能的特征组合中对预测结果的平均边际贡献，从而将模型的预测值公平地分配给各个特征。

一个可解释的模型 $g(z')$ 可以用所有特征的 SHAP 值 ϕ_j 线性相加来表示：

$$g(z') = \phi_0 + \sum_{j=1}^M \phi_j z'_j \quad (35)$$

在此式中， ϕ_0 代表了数据集中所有样本预测值的平均，也称为基准值。 ϕ_j 即为第 j 个特征的 SHAP 值，它量化了该特征将模型预测结果从基准值推向最终预测值的贡献大小和方向。正值的 SHAP 值表示该特征促使模型预测结果向正类别移动，负值则代表其作用相反。

10.3.2 基于 SHAP 的逻辑回归模型结果分析

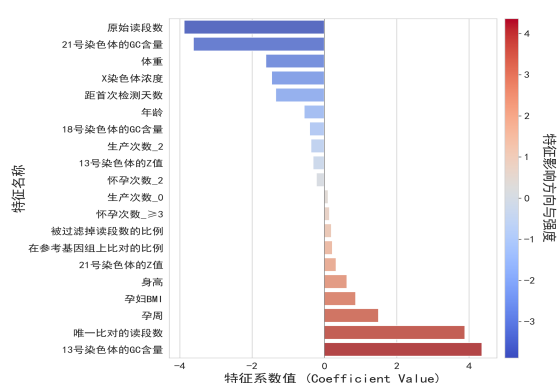


图 31 逻辑回归模型特征系数排序

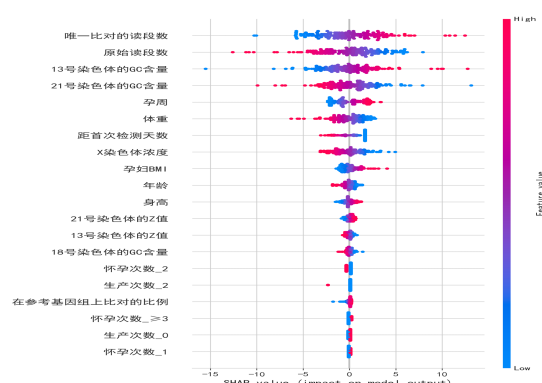


图 32 SHAP 摘要图

图 31与图 32分别从不同角度展示了模型的决策机制。图 31是逻辑回归模型各特征

的系数。横轴代表系数的大小，其正负号与数值决定了特征对判定结果为异常概率的影响方向和强度。图中显示，**13 号染色体的 GC 含量**与**唯一比对的读段数**具有最大的正向系数，约等于 4，表明这些指标数值的增加会使模型判定为异常的可能性显著上升。孕周与孕妇 BMI 等特征也表现出一定的正向影响。相反，**原始读段数**和**21 号染色体的 GC 含量**具有较大的负向系数，接近-4，说明这些指标数值的增加会降低模型判定样本为异常的可能性。

图 32通过 SHAP 值为我们模型的结果提供了更加深入的解释。图中每一行代表一个特征，按其对模型输出的平均影响大小排序。该图表明，**唯一比对的读段数**是对模型预测影响最大的特征，当其特征值较高时，SHAP 值普遍为正，增加了判定为异常的概率。原始读段数的影响力次之，其特征值较低时，SHAP 值倾向于为正。对于临床上普遍关注的指标，例如 21 号染色体的 Z 值，图中显示其数值越高，颜色越红，对应的 SHAP 值也越大，更倾向于将胎儿判定为异常

依据解释性分析的结果，对于女胎异常的判定主要依据**染色体读段数、GC 含量等临床与测序指标**。基于我们的判定方法，现实中妇幼医疗工作者可以重点关注以上胎儿指标进行风险评估，从做出更准确的诊断决策，减少患病风险。

参考文献

- [1] 张亮亮, 卓召振, 黄盛文, 任凌雁, 牟静, and 匡颖. 贵州省多中心 16798 例 nipt-plus 结果回顾性分析. 贵州医药, 49(08):1296–1299, 2025.
- [2] 张鹏, 莫伟英, 蒙明慧, and 张红燕. 无创产前检测对性染色体非整倍体检出情况的影响及相关伦理思考. 中国临床新医学, 18(06):690–695, 2025.
- [3] 钟佳通, 胡亮, 温丽娟, 李双武, 陈晓杭, 裴元元, and 刘维强. 双胎妊娠中无创产前检测的胎儿游离 dna 浓度特征及检测失败原因分析. 中国产前诊断杂志 (电子版), 15(03):25–30, 2023.
- [4] 蒋丽雅, 卢劭侃, 杜佳恩, 陈阔阔, 张思恬, 伍圣洁, 柳天玉, and 叶佳昊. 无创产前检测技术的发展与应用. 临床医学研究与实践, 10(23):191–194, 2025.